EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 76713
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-01-02 12:32:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: VALERIO ANTONIO APARICIO APARICIO			RUN	: 7.171.486-1
F.Nac	: 13-06-1953	Edad	: 70 AÑOS, 6 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: EL DURAZNO 0937 11 SEPT,			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-12-28	Fecha Egreso	: 2024-01-02 12:32:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- ACV frontomesial derecho Día 7. Obs embólico
- Hipertensión arterial
- OH crónico
- Obs. Traqueobronquitis

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes:
- HTA no controlada (abandono de tto hace 6 meses)
- Obs FA paroxística
- OH crónico

Familiar refiere que el 26/12/23 presentó pérdida subíta de conciencia, caída al suelo, recuperación lenta de nivel de conciencia con aparición de hemiparesia FBC izquierda. Cuadro descrito sugerente de arritmia cardiaca y cardiombolia.
TC cerebro s/c con signos hiperagudos de infarto ACA derecha, angioTC cerebro y cuello muestra oclusión focal de A2 derecha con recanalización distal e infarto agudo de territorio de ACA ipsilateral, sin TH.
Se hospitaliza para estudio y tratamiento. AngioTC cerebro y cuello de control sin cambios respecto al inicial (sin recanalización de oclusión en A2 derecha, infarto sin TH, sin nuevas lesiones), TC tórax sin patología pulmonar infecciosa aguda.
En cuanto a lo neurológico se mantiene sin fluctuación. Se mantiene en seguimiento por fonoaudiología para rehabilitación de habla y deglución, buen rendimiento al uso de régimen papilla. En cuanto a lo kinésico con necesidad de asistencia máxima en SBC.
Sin registro de arritmias. Aun pendiente estudio de cardioembolías que se considera realizar en forma ambulatoria. En cuanto a lo infeccioso sin cambios con parametros inflaatorios estacionarios, sin embargo con tos.
Considerando mejor perfil de presiones arteriales y buena tolerancia a la alimentación oral. Se decide alta a hospitalización domiciliaria para rehabilitación

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistidoy vigilado. Pasar a sillón en forma diaria
2. Régimen papilla hiposódico

3. Clopidogrel 75 mg, 1 comp al día, vía oral
4. Atorvastatina 20 mg, 1 comp por noche, vía oral.
5. Carvedilol 25 mg, 1/2 comp cada 12 horas, vía oral.
6. Famotidina 40 mg, 1 comp al día, vía oral.
7. Hidroclorotiazida 50 mg, 1/2 comp al día, vía oral.
8. Amlodipino 10 mg, 1/2 comp al día, vía oral.
9. B Ipratropio 2 puff cada 8 horas + SOS, con aerocamara
10. Cloranfenicol colirio, 2 gotas cada ojo por 4 veces.
11. Polietileglicol 1 sobre al día hasta deposiciones.
12. Amoxicilina/Ac Clavulánico (875/125) 1 cada 12 horas por 5 días, vía oral.
13. Sertralina 50 mg, 1 comp al día, vía oral.
14. Pendiente Holter de ritmo y ecocardiograma TT
15. Kinesioterapia motora
16. Fonoaudiología
17. Control GES ACV en CAE HSC
18. Control SOS en SU de HSC

EXÁMENES Y RESULTADOS

- 02/01/24 Creat 0.8, MDRD 95.57, Uremia 54, BUN 25, ELP 139/4.5/107, Hb 15.2, Hto 45.6, Leuco 11800, plaq 352.000, VHS 45, PCR 50.5. Procalc 0.05
- 30/12/23 Creat 0.8, MDRD 95.57, uremia 36, ELP 136/4.2/104, Hb 15.6, Hto 47.4, Leuco 13400, plaq 310.000, VHS 34, PCR 43. INR 1.13. Procalc 0.06
- 28/12/23 VitB12 246, RPR no reactivo.
- 26/12/23 angioTC de cerebro y cuello: hipodensidad frontomesial derecha.
- 26/12/23 Glic 174, Creat 0.6, MDRD 133, Uremia 51, ELP 134/4.5/104. Hb 15.5, Hto 47.4, Leuco 12900, plaq 302.000, VHS 24, PCR 9.0. ColT 249, HDL 56, LDL 131, TGL 310. TSH 1.05, T4 8.7, HbA1c 5.0
- 23/12/23 angioTC de cerebro y cuello con oclusión de A2 derecha
- 26/12/23 TC de encéfalo sin contraste: hipodensidad frontal mesial derecha compatible con infarto agudo.

OBSERVACIONES:

SV FC 63 lpm RR, T° 36.2°C, PA 150/78mmHg, Sat 94%, HGT 139
- Bien perfundido, piel humeda. Sin signos de flebitis.
- Cardiaco RR2T no logro auscultar soplos
- Pulmonar MP+ SRA
- Abdomen BDI RHA (+)
- EEII sin edema, sin signos de TVP. Pulsos pedios simétricos. Con flexión de cadera y dolor a la movilización pasiva

Al examen neurológico:
- Vigil, desorientado en tiempo y espacio, inatento. Sin alteración de lenguaje, disartria leve, hipofonia
- Pupilas isocoricas, RFM +/+, CV normal. OCM normal. Sensibilidad facial normal. mueca simétrica. Protruye lengua en linea media
- Hemiparesia izquierda braquial M2, crural M4- limitado por impotencia funcional. Plantar extensor izquierdo.
- Sin alteración sensitiva de hemicuerpo izquiero
- Coordinacion no coopera
- Signos meningeos negativos.

MEDICO TRATANTE

JEFE SERVICIO